

34. 質問 J2

所要時間 : 08:08

学習シート

コース概要

このビデオでは、頭蓋オステオパシーにおける脳の動きの重要性を探り、身体が知的な存在として自律的に発達する方法を強調しています。主要な概念には、内臓頭蓋、心臓、横隔膜、免疫システム間のつながりが含まれ、あるレベルでの機能不全が他のシステムに影響を与える可能性があることを示しています。横隔膜と臓器機能の相互接続が強調され、患者の生活の質を向上させるために横隔膜のダイナミクスに取り組むことの重要性が強調されています。実践的な演習と理論的な概念は、相互接続された身体構造のバランスをとる方法に関する学習をサポートします。

34. 質問 J2：生体力学的発生学と人体

脳の動き：頭蓋オステオパシーの基礎

脳の発達の動きは根本的であり、**頭蓋オステオパシー**に深い意味を与えます。人体は本質的に知的であり、自身の発達経路を知っています。

私たちの役割は脳を再教育することではなく、脳に耳を傾けることを学ぶことです。脳が私たちを教え導いてくれるでしょう。

私たちは「**脳の太極拳**」を行うことを学びます。**頭蓋底**が脳と密接に結びついていることを観察します。**脳室系**と**脳の深部流動**は、そのダイナミクスに依存しています。

同様に、**膜系全体**（張力膜、大脳鎌、小脳テント、小脳鎌、硬膜、頭頂膜、内臓膜）は脳のダイナミクスに依存しています。頭蓋底の密な構造から頭蓋冠に至るまでの脳のこの区画化は、このダイナミクスを反映しています。

内臓頭蓋と有機的結合

内臓頭蓋を、**横中隔**から始めて研究します。横中隔は、心臓、横隔膜を含む組織統合であり、**鎌状靱帯**へと続いています。

この構造は、心臓と肝臓の間の初期の機能的統合を明らかにしています。これは**ウィンスロー孔**を介して続き、**大網**を形成します。

暗黙の関係

これは、以下の間に根本的な関係があることを意味します。

- 心臓
- 横隔膜
- 脳
- 免疫系

したがって、心臓または頭蓋底のレベルでの不安定化は、免疫系に影響を与える可能性があります。上部免疫系である**ワルダイエル-ハイナー環**（扁桃）はその一例です。

耳鼻咽喉科領域への影響

このレベルでの機能不全は、重大な影響を及ぼす可能性があります。例えば、**耳鼻咽喉科**の問題を抱える多くの子供たちは、分子レベルで盲腸に見られるものと同じ**免疫グロブリン**（タイプ1）を持っています。

したがって、**腹膜**の不安定化は、耳鼻咽喉科領域全体に影響を与える可能性があります。実際には、耳鼻咽喉科領域のバランスを再調整するには、腹膜、特に扁桃と同じリンパ組織を含む盲腸レベルのバランスを再調整することがしばしば必要です。かつて、扁桃と虫垂の切除がしばしば同時に行われていたことは興味深いことです。

食道とその相互接続

食道の関係もまた重要です。**食道間葉**は横隔膜の機能に影響を与える可能性があります。

胃と食道は、**頸動脈孔**、**翼突筋叢**、および**翼突筋**を介して頭蓋底まで吊り下げられています。したがって、頭蓋底の不安定化は、**心臓-食道接合部**の機能、ひいては私たちの生理機能に不可欠な横隔膜の動きを変化させる可能性があります。

中胚葉壁と横隔膜

側方中胚葉壁（側壁）も非常に重要です。**肋骨弓**は、横隔膜の適切な機能に完全に依存しています。

したがって、背部全体がこのダイナミクスに関連しています。さらに、**腎臓**、**大腰筋**、**十二指腸**との接合部も確認され、システムの全体的な統合が強調されています。

横隔膜の重要性

私たちは、横隔膜をより繊細に、遠隔からでもそうでない場合でも、扱うことを学ぶ必要があります。この横隔膜を拡張することで、患者の生活の質が大幅に向上します。

横隔膜の運動を行う際、不可欠な参照点はその**支点**です。この支点を空間の動的な不動性に吊り下げることが可能です。

それは蝶番、「**ヒッチポイント**」または支点を持つ開閉するドアのようなものです。この出発点は動いているように見えるかもしれませんが、深く掘り下げると、それは固定点、あなたの参照点になりますが、常にシステムの動的な不動性に吊り下げられています。

心臓、腹膜、および胚の動き

食道間膜と**下大静脈**に関する疑問が生じます。下大静脈は心臓に非常に近く、ほとんど同じ軸上にあり、肝臓からもそれほど離れていません。

脊索の最初の大きな動きと、**羊膜腔**の2番目の円形の動きは、心臓と腹膜に特定される内臓の中心を含んでいます。

巻き込みのイメージ

イメージは、関節のように**心臓-胸膜-腹膜系**の周りの**巻き込み**です。**神経管**は前方に強く発達し、心臓を牽引しますが、後方にも成長し、前方の制限領域によって尿膜管をもたらします。

これは、**胚茎**による体の閉鎖の動きがあることを意味します。この時点で、尿膜管と心臓が統合され、支点となります。

横中隔の起源

この段階で、2つの要素が重要です。南側の部分と**卵黄嚢**の上部を押す心臓です。この押し出しが**横中隔**を方向付け、組織化します。

その組織の起源はすでに存在していましたが（細胞はそこにありました）、脳と心臓、そして心臓と卵黄嚢の間のこの出会いが、横中隔の形成に拍車をかけます。このように、心臓は脳と横隔膜の間の関節として機能します。